

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE BAISSSE DE L'ACUITE VISUELLE

I. Introduction - définition

Introduction-épidémiologie

- Acuité visuelle est le pouvoir que possède l'œil à distinguer deux points très proches l'un de l'autre
- BAV : diminution de l'acuité visuelle

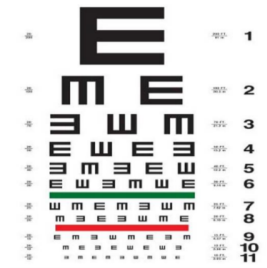
Rappel - Physiopathologie:

II. Orientation diagnostique

1. Interrogatoire

- Age, sexe
- Origine
- Profession
- ATCDs pathologiques : personnels, familiaux, généraux et ophtalmologiques
- Date d'apparition : rapide-progressif
- 2 questions :
- Notion de traumatisme
- Les signes accompagnateurs
 - Douleurs oculaires / rougeur oculaire
 - Photophobie / larmoiement

La BAV est appréciée par l'échelle de lecture de type Snellen qui explore le fonctionnement de la rétine maculaire



2. Examen clinique : bilatéral, comparatif, systématisé

- Acuité visuelle** : sans ou avec correction, de loin et de près
- Examen des annexes**
- Cornée** : transparence, test à la fluorescéine
- Chambre antérieure** : profondeur, calme ou inflammatoire
- Pupille** : réflexe photomoteur
- Cristallin**
- Tonus oculaire**
- Humeur vitrée**
- Fon d'œil**
- Œil controlatéral et examen général +++**

3. Examens complémentaires

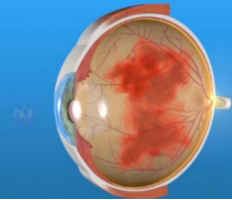
- Echographie
- Angiographie
- OCT
- Champs visuel
- Potentiels évoqués visuels, ERG = électrorétinogramme
- TDM
- IRM

III. Orientation étiologique

1. BAV brutale ou rapidement progressive

a. Œil rouge et douloureux

- 3 grands diagnostics : GAFA, uvéite antérieure, kératite

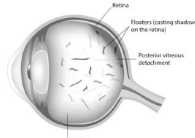


Tyndall intra-vitréenne

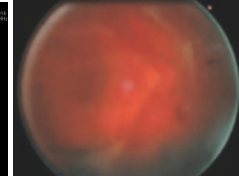
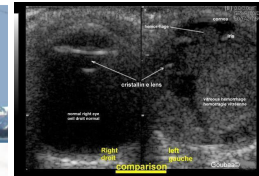
b. Œil blanc et indolore

i. Hémorragie intra vitréenne

- BAV
- Myodesopsies
- Fond d'œil : reflet rougeâtre = échographie (Pour éliminer une déchirure ou un décollement rétinien)



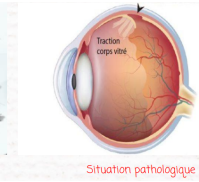
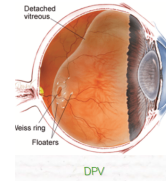
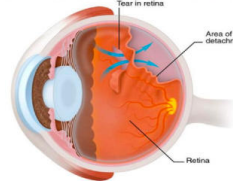
Myodésopie



hémorragie intra-vitréenne

ii. Décollement de rétine

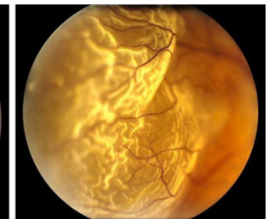
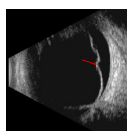
- BAV
- Amputation du champ visuel
- Phosphènes
- Myodesopsies = Sensation de mouches volantes
- Hypotonie oculaire
- Fond d'œil :
 - Soulèvement rétinien sous forme d'une poche grise, saillante, mobile
 - Présence ou non d'une ou plusieurs déchirures rétinien
- Echographie : si trouble des milieux



DPV

Myodésopie

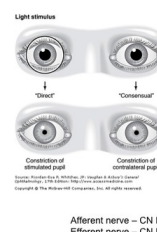
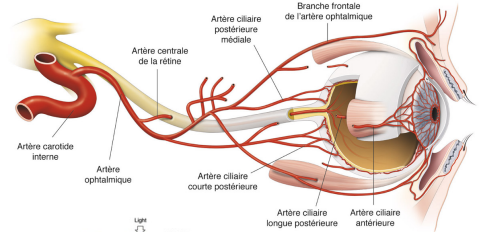
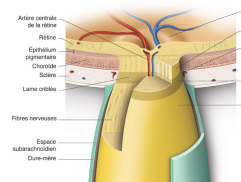
Situation pathologique



Photos de décollement de rétine

iii. Occlusion artérielle rétinienne

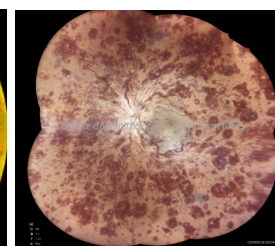
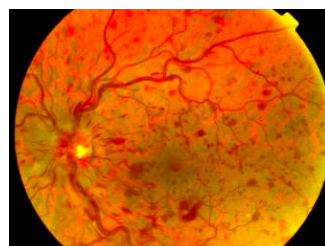
- Si occlusion de l'artère centrale de la rétine :
 - BAV brutale, maximale
 - Réflexe photomoteur aboli : mydriase
 - Champ visuel détruit
 - Fond d'œil :
 - Rétine pâle, ischémique
 - Macula : rouge cerise
 - Vaisseaux grêles et déshabités
- Si occlusion d'une branche de l'artère centrale de la rétine :
 - BAV progressive
 - Amputation du champ visuel limitée au territoire de l'artère occluse
 - Fond d'œil : œdème rétinien blanc ischémique dans le territoire de l'occlusion
 - Angiographie +++



Afferent nerve - CN II
Efferent nerve - CN III

iv. Occlusion veineuse rétinienne

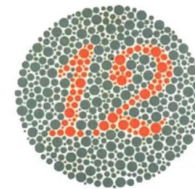
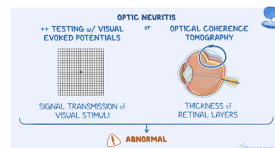
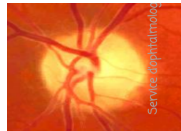
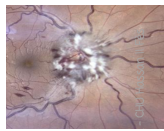
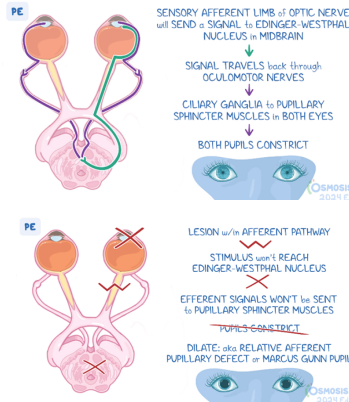
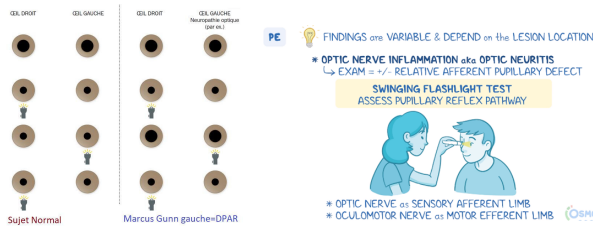
- Si occlusion de la veine centrale de la rétine :
 - BAV rapidement progressive-brutale
 - Amputation du champ visuel
 - Fond d'œil :
 - Dilatation des veines rétinien
 - Œdème rétinien
 - Hémorragies rétinien
 - Nodules cotonneux
- Si occlusion d'une branche de la veine centrale de la rétine :
 - BAV modérée
 - Amputation du champ visuel limitée au territoire lésé
 - Fond d'œil :
 - Dilatation des veines rétinien



- Œdème rétinien
- Hémorragies rétinien
- Nodules cotonneux
- Angiographie +++

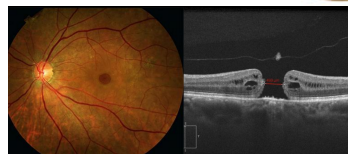
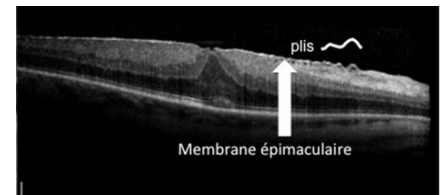
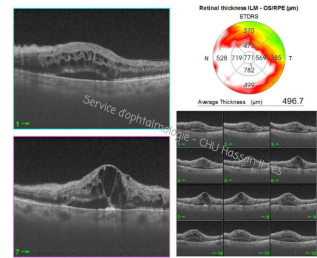
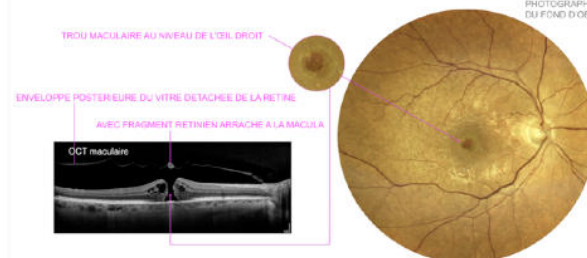
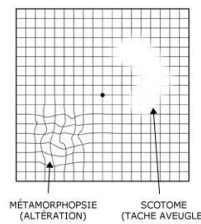
v. Neuropathies optiques

- BAV
- Altération du réflexe photomoteur
- Atteinte du champ visuel
- Fond d'œil :
 - Papille normale = neuropathie rétrobulbaire style sclérose en plaques
 - Œdème papillaire
 - Atrophie papillaire
- Angiographie +++
- Potentiels évoqués visuels :
 - Diminution des amplitudes
 - Augmentation des temps de latence
- Perturbations des la vision des couleurs : **dyschromatopsie d'axe vert-rouge**



vi. Maculopathies

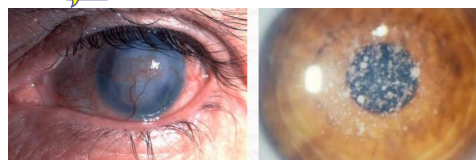
- BAV plus prononcée de près
- Métamorphopsies : troubles de la vision des formes
- Micropsies : voit les objets plus petits qu'ils ne le sont
- Scotome central
- Fond d'œil :
 - Décollement maculaire
 - Œdème maculaire
 - Foyer chorio-rétinien
 - Trou maculaire
 - Membrane épimaculaire
- Angiographie
- Tomographie à cohérence optique +++



2. BAV lentement progressive et ne pouvant être améliorée par des verres correcteurs

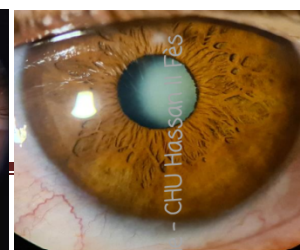
a. Atteintes cornéennes

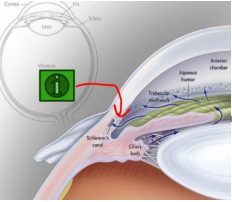
- Œdème cornéen
- Dystrophie cornéenne
- Opacité cornéenne



b. Cataractes

- Eblouissement en lumière vive
- Opacification du cristallin
- Pupille blanche : leucocorie
- Fond d'œil :
 - Lueur pupillaire
 - Non explorable

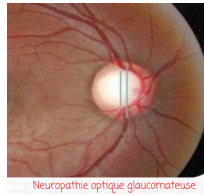
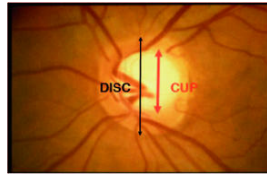




c. Glaucome chronique à angle ouvert



- BAV (si on en arrive à la BAV, on est au stade terminal de la pathologie)
- Hypertonie oculaire
- Angle iridocornéen ouvert
- Excavation papillaire
- Champ visuel altéré



d. Rétinopathie pigmentaire : affection génétique



- BAV/héméralopie+++
- Patient jeune : 18-20 ans
- Rétrécissement du champ visuel périphérique
- Le patient dit que tant qu'il y a de la lumière ça va et vers le soir, impossible qu'il se déplace seul
- Fond d'œil :
 - Pâleur papillaire
 - Aspect grêle des vaisseaux rétinien
 - Pigments dispersés
- Aucun traitement pour cette maladie : essayer d'orienter le choix professionnel du patient



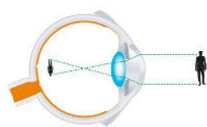
e. Uvéites postérieures :

- BAV
- Brouillard visuel
- Myodesopsies
- Fond d'œil :
 - Trouble vitréen
 - Vascularité rétinienne
 - Foyer chorio-rétinien

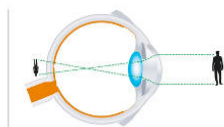
3. BAV prolongée pouvant être améliorée par des verres correcteurs



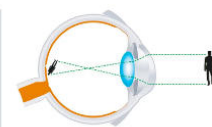
- Myopie :
 - BAV en vision de loin
 - Bonne acuité visuelle en vision de près
- Hypermétropie
 - Gène de la vision en vision de près
 - Puis gène de la vision en vision de loin
- Astigmatisme
- Presbytie



Myopia



Hyperopia



Astigmatism

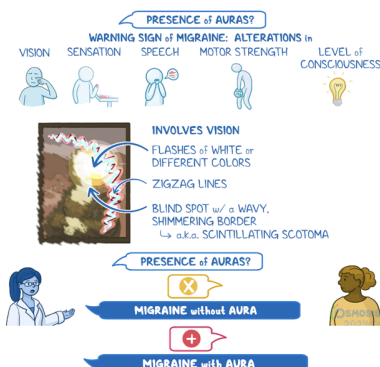
4. BAV transitoire



- Migraine ophtalmique : migraine avec aura
- Cécité monoculaire transitoire
- HTIC : BAV variable en fonction de l'intensité de l'HTIC

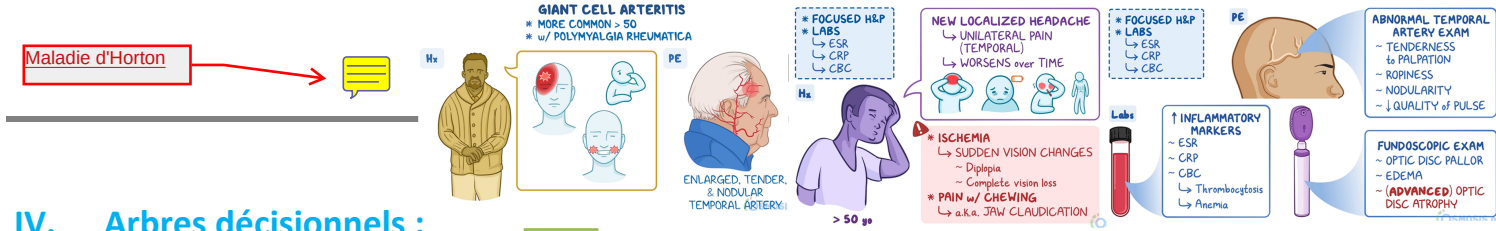
TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK or "TIA"

- * SYMPTOMS RESOLVE in 24h (MIN - HRS)
- * BRIEF EPISODE of NEUROLOGICAL DYSFUNCTION
 - ↳ LOSS of BLOOD FLOW & ISCHEMIA in BRAIN, SPINAL CORD, or RETINA
 - ↳ w/o CELLULAR DEATH or IRREVERSIBLE EFFECTS
- * ABSENCE of INFARCTS on CT or MRI CAN CONFIRM DIAGNOSIS
- * MANAGED by FIGURING out RISK of SUBSEQUENT STROKE:
 - ↳ AGE
 - ↳ BLOOD PRESSURE
 - ↳ CLINICAL FEATURES
 - ↳ DURATION of TIA
 - ↳ DIABETES
- * HIGH RISK = HOSPITALIZATION & MONITOR 1 DAY REQUIRED



Remarques

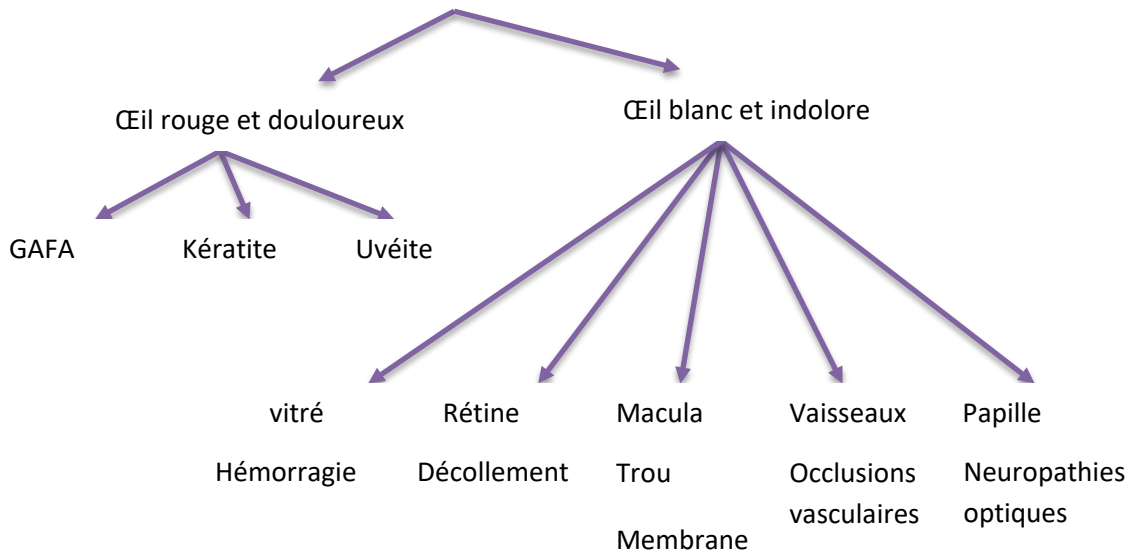




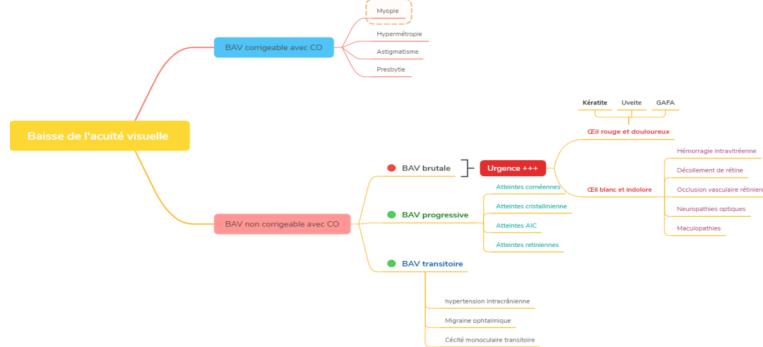
IV. Arbres décisionnels :

QE!!

Baisse de l'acuité visuelle, brutale ou rapidement progressive



Œdème



Baisse d'acuité visuelle lentement progressive

